Ambulantní zpráva

Pacient: Josef Novák, nar. 5. 1. 1966, RČ 660105/••••, pojišťovna 111
Datum vyšetření: 6. 1. 2026
Odesílající: MUDr. Jana Dvořáková, praktický lékař, Benešov

Důvod vyšetření

Nebolestivý ikterus od 5. 1. 2026, odeslán praktickým lékařem k došetření.

Anamnéza

DM 2. typu na PAD, arteriální hypertenze. Úbytek hmotnosti 4 kg za 2 měsíce, acholická stolice, tmavá moč. Nekuřák, alkohol příležitostně. RA: otec karcinom prostaty, jinak bez nádorů GIT.

Farmakologická anamnéza

Metformin 1000 mg 1-0-1, Ramipril 5 mg 1-0-0. Antikoagulancia ani antiagregancia neužívá. Alergie: penicilin.

Objektivně

Ikterus kůže a sklér, břicho měkké, nebolestivé, bez hmatné rezistence, játra nezvětšena.

Celkový stav: soběstačný, chodí bez pomoci, běžné denní činnosti zvládá, těžší fyzickou práci již ne, většinu dne mimo lůžko – výkonnostní stav ECOG 1.

Laboratoř (odběr 6. 1. 2026, OKB Nemocnice Benešov)

Vyšetření	Výsledek	Ref. meze	
Bilirubin celkový	186 µmol/l	2–17	↑
ALP	4,2 µkat/l	0,7–2,2	↑
GMT	7,8 µkat/l	0,1–1,2	↑
ALT / AST	3,1 / 2,4 µkat/l	do 0,8	↑
CRP	12 mg/l	do 5	↑
Leukocyty	7,9 × 10⁹/l	4,0–10,0	
Hemoglobin	128 g/l	135–175	↓
Trombocyty	245 × 10⁹/l	150–400	
INR	1,1	0,8–1,2	
aPTT	31 s	25–38	
CA 19-9	389 kU/l	0–37	↑
CEA	4,1 µg/l	0–5	

Zobrazovací vyšetření

UZ břicha 6. 1. 2026: hypoechogenní ložisko v hlavě pankreatu cca 32 mm, dilatace intra- i extrahepatálních žlučových cest.

CT břicha zatím neprovedeno – doporučeno CT podle pankreatického protokolu v KOC.

Histologie

Dosud není k dispozici.

Závěr a doporučení

Obstrukční ikterus, suspektní tumor hlavy pankreatu. Doporučeno odeslání do KOC VFN Praha k CT (pankreatický protokol), ERCP s drenáží žlučových cest a EUS-FNB dle rozhodnutí KOC. Pacient poučen.

MUDr. Pavel Kratochvíl, internista · 6. 1. 2026